

Agosto: 2 suspensiones en 152 cirugías programadas

1,32 %

tasa hábil de suspensión · agosto 2026

cirugía mayor electiva programada de lunes a viernes ·
misma fórmula y fuente de todos los meses

12,11 %

agosto 2025 a la misma fecha · 23 de 190

+13,5 %

cirugía mayor hábil · enero–agosto vs 2025

12 de 21 días

sin Pabellón 2 en agosto · explica la menor producción del mes

Versión breve para el comité · la versión completa (49 láminas, métodos y tablas) queda como anexo.

La suspensión de agosto cayó a la décima parte de la de 2025

12,11 %



1,32 %

agosto 2025

23 suspensiones de 190 programadas

agosto 2026

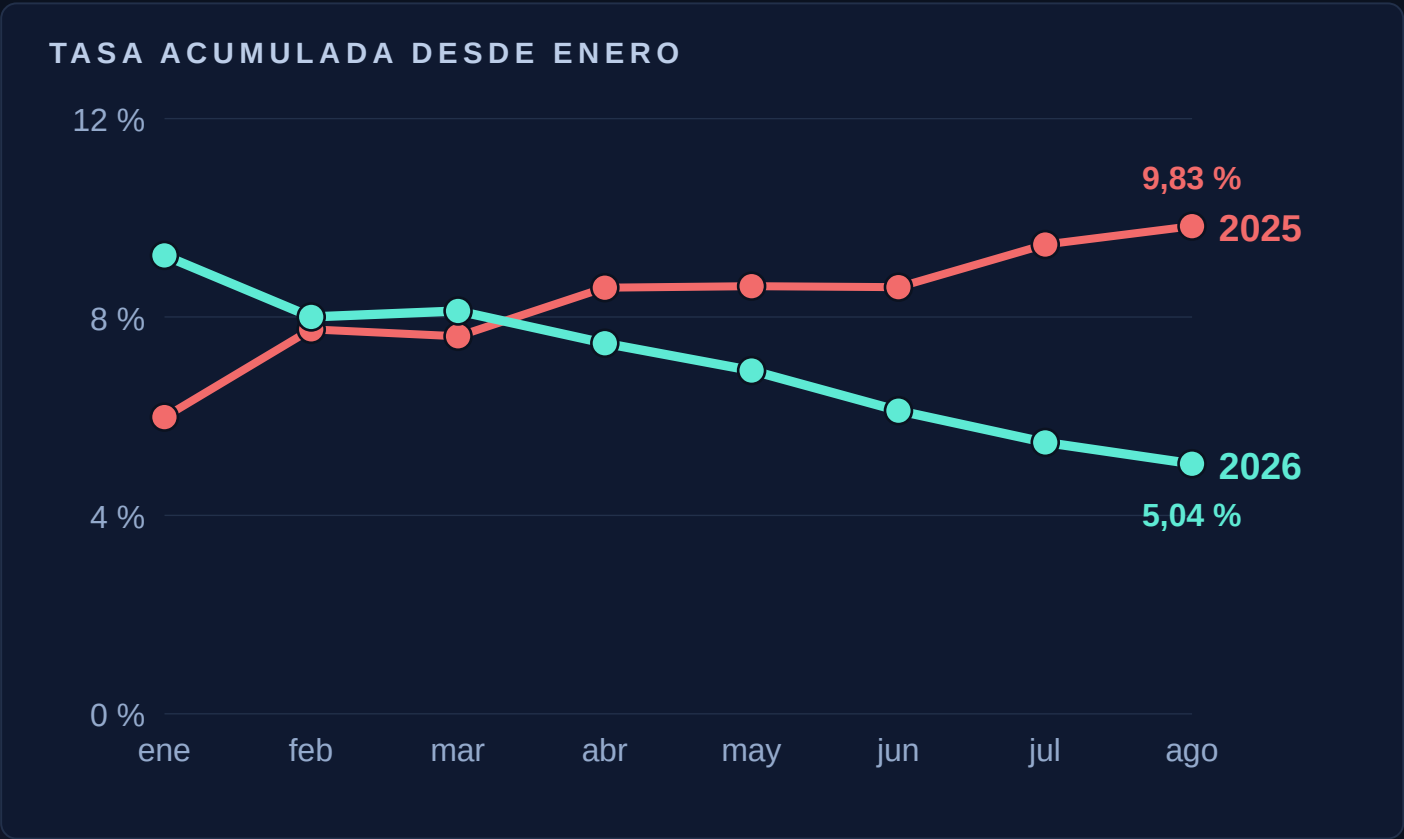
2 suspensiones de 152 programadas

12 pacientes operados que, al ritmo de 2025, se habrían suspendido

Con la tasa de 2025 se esperaban 14 suspensiones sobre 152 programadas; hubo 2. Diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,001$).

Cirugía mayor electiva programada de lunes a viernes (monitoreo diario). Misma fórmula en ambos años.

En el año llevamos 70 suspensiones menos que al ritmo de 2025



70
suspensiones evitadas
144 esperadas al ritmo 2025 · 74 reales

133 → 74
suspensiones enero-agosto
con 8,6 % más cirugías programadas

9,83 → 5,04 %
tasa acumulada a agosto
diferencia significativa (p < 0,001)

Acumulado = suspendidas / programadas desde enero (suma sobre suma). "Evitadas" es un cálculo aritmético; no atribuye causa.

Tres meses seguidos bajo el límite de control: la mejora es real



Un mes con 1–2 casos varía por azar; la evidencia está en la secuencia de tres meses y en el acumulado.

Producimos más cirugía mayor en horario hábil que en 2025

+13,5 %

cirugía mayor electiva de lunes a viernes

1.657 → 1.880 operaciones entre enero y agosto · los mismos
173 días hábiles

+2,4 %

todas las fechas · 3.307 → 3.386

-8,7 %

fin de semana · jornadas de oftalmología

+14,1 %

cirugía mayor de urgencia

Agosto: 411 cirugías mayores electivas (201 en horario hábil) frente a 419 en agosto 2025, con un pabellón menos parte del mes.

Julio y agosto se operaron con un pabellón menos

9 de 21

días con Pabellón 2 en agosto

tres lunes sin enfermera y obras en la cubierta desde el 12 de agosto

≈ 48 cirugías

electivas no realizadas por los 12 días perdidos

3,9 por pabellón-día

el rendimiento por pabellón se mantuvo

11,8 por día

cirugías mayores L-V con P2 completo · agosto 2025: 11,0

Estimación con la productividad observada por pabellón-día. Julio: falta confirmar los días sin pabellón para aplicar la misma regla.

Hubo 38 suspensiones en total; solo 2 cuentan para el indicador

38

suspensiones registradas
todas las modalidades y días

19 + 19

lunes a viernes + fin de semana
18 son oftalmológicas de dos jornadas

18

sin causa registrada
casi la mitad del registro

Las 18 oftalmológicas no son 18 fallas: son dos jornadas (8–9 y 22–23 de agosto)

Concentración imposible por azar ($p < 0,001$). Falta registrar la causa por jornada: capacidad, dotación, insumos o inasistencia.

El indicador oficial cuenta solo la cirugía mayor electiva de lunes a viernes; el resto consume preparación, agenda y pabellón igual, pero no se ve.

La causa número uno es el error de programación

**10****evitables**

programación, ayuno, exámenes, instrumental

5 + 5**potencialmente evitables + no evitables****18****sin causa registrada**

no se clasifican

Rojo: evitable · ámbar: potencialmente evitable · azul: no evitable. Julio tuvo 5 errores de programación; agosto 7.

El lunes sigue siendo el día frágil de la semana

6 de 19

registros de lunes a viernes fueron en lunes

2 de 2

eventos del indicador cayeron en lunes

3 lunes

sin tabla en Pabellón 2 por falta de enfermera

Histórico: el lunes suspende 11,09 %, más que cualquier otro día (significativo)

Medida: confirmar pacientes y exámenes el viernes en la tarde, y asegurar la dotación de enfermería del lunes en Pabellón 2.

Agosto solo no alcanza para demostrarlo ($p = 0,16$); el histórico de 16 meses sí ($Z = 2,09$).

El día quirúrgico de agosto, en un solo caso

UN CASO ELECTIVO TÍPICO DE LUNES A VIERNES · MINUTOS (MEDIANAS)



De la entrada a la salida del quirófano: 100 minutos de mediana. Luego 18 minutos de recambio y entra el siguiente.

07:55

entra el primer paciente

7 minutos antes que en julio

08:45

primera incisión

45 minutos después de entrar

18 min

recambio entre pacientes

igual que en julio (19)

Medianas del export SITGEQ 830 (agosto, lunes a viernes, electivos). Las 08:00 y 09:00 son referencias, no metas.

Los recambios largos se acortaron; el caso típico no cambió

18 min

recambio · mediana

julio 19 · sin cambio

22,6 min

recambio · media

julio 29,5 · -7 min

43 min

recambio · uno de cada diez supera

julio 59 · -16 min

Mejor

El primer paciente entra a las 07:55 (julio 08:02) y la primera incisión es a las 08:45 (julio 08:50).

Pendiente

Solo 63 % de las primeras incisiones ocurre antes de las 09:00 (agosto 2025: 85 %). El mediodía suma 33 horas sin actividad.

Recambio neto: de la salida de un paciente al ingreso del siguiente, descontando el almuerzo (12:30–14:00).

Qué esperar si el régimen se sostiene, y qué pasa si no

2 a 10

suspensiones en septiembre

pronóstico prudente · más de 10 es señal de deterioro

9 · 29 · 69

septiembre a diciembre

si se sostiene · si sube a 4 % · si vuelve 2025

66 vs 505

al año en el HPMM (7 pabellones)

régimen actual vs tasa 2025 · 439 pacientes de diferencia

El traslado al Marga Marga multiplica por 2,3 la exposición: amplifica la tasa que llevemos

Sostener el régimen depende de lo que se institucionalice antes del traslado: causal completa, lunes blindado, dotación y camas de rescate.

Escenarios binomiales con el volumen de cada período; no incorporan estacionalidad ni cambio de mezcla.

Cinco decisiones para septiembre

1

Completar la causa de las 38 suspensiones

por jornada en el fin de semana; "sin causa determinada" disponible

2

Blindar el lunes y recuperar el pabellón-día

confirmación el viernes en la tarde · enfermería asegurada en Pabellón 2

3

Auditar el error de programación

7 casos, 3 cirugías mayores directas · separar error de agenda de indicación o insumo

4

Consentimiento y ayuno antes de la tabla

medida del 31 de agosto: sin consentimiento firmado no hay tabla

5

Registro operable y piloto de almuerzo

campos de julio en CancelOS · cobertura de 4 semanas con hitos de sala, paciente y URPA

De dónde salen las cifras

Monitoreo diario (ene-2025 → ago-2026)	tasa de suspensión, producción, comparación con 2025 y control estadístico
Informe de suspensiones de agosto (2-sep)	las 38 suspensiones: causas, día, modalidad y evitabilidad
Exports SITGEQ 787 y 830	tiempos: primer caso, recambio, ocupación, pabellón y especialidad
Informe "Evolución del proceso quirúrgico" (6-sep)	series de recambio y primeros casos 2024–2026; evaluación de algoritmos
Comité de julio y SPC histórico	regla de evitabilidad, línea base 2025, efecto lunes y proyección HPMM

Anexo: la versión completa (49 láminas) tiene los métodos, las tablas, las pruebas estadísticas y las notas de cada cifra.

Información agregada, sin datos personales. Los identificadores se usan solo para conciliar fuentes.